جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * **طلب علاج أول مرة / متردد**

إسم المريض رباعياً : نعمه السيد حسنين عبدالدايم

المحافظة : الجيزه **الحي / المدينة :** امبابه **العنوان :** امبابه

رقم البطاقة : 28209302102084 **رقم التليفون :** 01114786281 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026

العمر(تاريخ الميلاد) : 30-09-1982**المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**

التوقيع:(---------------------------) **التوقيع:(---------------------------)**

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام مزيد من الابحاث و الاشعات [7954] **قسم العلاج :** الاورام

التعليق على التشخيص : ---------------------------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني	**الوظيفة:** ---------------------------	**التوقيع:** د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن	**الوظيفة:** ---------------------------	**التوقيع:** د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان	**الوظيفة:** ---------------------------	**التوقيع:** نرمين رمضان

جوستاف روسي

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ------------------------ **ا.د/** ------------------------ **د/** ------------------------ **د/** ------------------------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : --

خطة العلاج : --

المستشفي : --- **قسم :** --

جهة العلاج : --- **نفقات :** --

ملاحظات : --

رئيس **المجلس الطبي المتخصص**	**مدير عام** **مديرية الشئون الصحية**	**ختم** **شعار الجمهورية**

Name: نعمه السيد حسنين عبدالدايم
National ID: 28209302102084

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

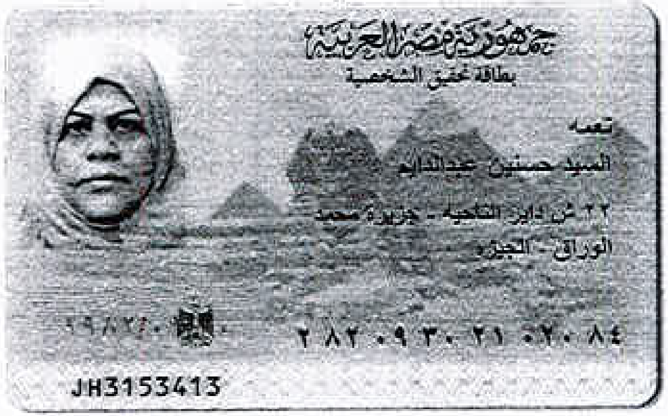
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : yyyy-mm-dd --:-- --	**تاريخ وساعة الخروج :** 05-07-2026 01:17 PM

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Further investigations and imaging**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



جمهورية مصر العربية
بطاقة تحقيق الشخصية

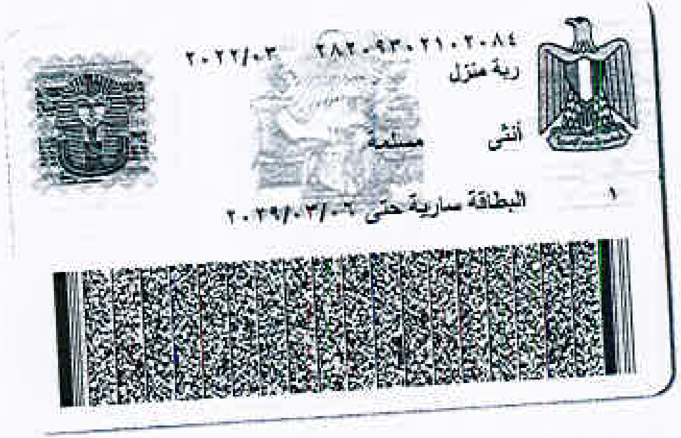
نعمه
السيد حسنين عبدالدايم
٢٢ ش داير الناحية - جزيرة محمد
الوراق - الجيزة

٠٩٨٣٤٠

٢٨٢٠٩٣٠٢١٠٢٠٨٤

JH3153413

National ID · Front
[[DOCTYPE:ID_FRONT]]



٢٨٢٠٩٣٠٢١٠٢٠٨٤ ٢٠٢٢/٠٣

ربة منزل

أنثى مسلمة

١

البطاقة سارية حتى ٢٠٢٩/٠٣/٠٦

National ID · Back
[[DOCTYPE:ID_BACK]]

Name: نعمه السيد حسنين عبدالدايم

MR. : 3005

Detailed Medical Report

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من

بشأن تقرير طبي للمريض

بقسم:

رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول :

تاريخ وساعة الخروج :

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه

The patient was diagnosed with a premenopausal right-sided breast cancer, clinical stage T2 N2, with multicentric disease. Imaging showed estrogen-receptor (ER) 8/8 positive, progesterone-receptor (PR) 8/8 positive, HER2 2+ (negative by FISH), and Ki-67 10 %. The initial treatment plan was neoadjuvant AC (doxorubicin and cyclophosphamide) for clinical stage cT4 disease.

The patient, now described as remenopausal, continued to have right-sided breast cancer, clinical stage cT2 N2, with the same receptor profile (ER 8/8, PR 8/8, HER2 2+, Ki-67 10 %). She was noted to be receiving a C2 TXT regimen and reported diarrhea as a symptom.

The patient, a 43-year-old premenopausal individual, completed neoadjuvant chemotherapy with AC and taxane (TXT). She subsequently underwent a modified radical mastectomy on 20 May 2026, with final pathology showing ypTis ypN0 (0/12 nodes). Post-operative multidisciplinary discussion recommended adjuvant endocrine therapy with femara (letrozole) ± zoladex (goserelin); however, endocrine therapy had not yet been approved. Laboratory evaluation for estradiol (E2) and follicle-stimulating hormone (FSH) was ordered to confirm menopausal status.

Laboratory results on 3 August 2026 demonstrated E2 55 pg/mL and FSH 25 mIU/mL, consistent with a premenopausal hormonal profile. The patient reported regular menstrual cycles prior to chemotherapy and remained premenopausal. The multidisciplinary team recommended initiation of an aromatase inhibitor with zoladex according to MDT guidance, and advised a dexamethasone scan followed by a consultation for zoledronic acid (Zometa).

تحريرا في ,

التاريخ : 18-09-2026

الوقت :

الطبيب المعالج : هنا اسامه عبد الرحيم عبد البر

يعتمد ,

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

05/11/2026

MDT FORM

Name:	Nemaa El-Sayed Hassanen Abd Eldayem		
Age:	44 Y	**MRN:**	3005
Menopausal Status:	PREMENOPASUAL	**ID:**	28209302102084
NRS SCORE:		**Phone:**	
BMI:		**Marital Status:**	Divorced
CO Morbidity:	HTN, DM	**Family History:**	Negative
		Reason Of MDT:	Post NACT

Clinical Data:

BX: IDC

ER: 8/8 **PR:** 8/8 **HER2** +1 **KI67:**

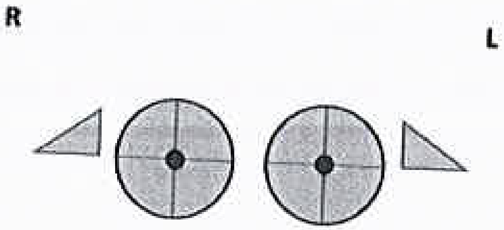
Sonomammography:
Multiple residual masses, No path LNs

Mets Workup:
Exam: palpable residual mass, no ax LNs

History:
Multicentric Rt breast cancer 6,11,12,11-12' o'clock

Recommendations:
For Rt SM & SLN

MDT Outcome & Plan
Rt SM & SLN



TNM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
د/ نرمين مصطفى	د/ جمال عمره				

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

NHTMRI

الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية
المعهد القومى للكبد والجهاز الهضمي
والأمراض المعدية

قسم الباثولوجي

PATHOLOGY DEPARTMENT
HISTOPATHOLOGICAL REPORT

Patient name: نعمه السيد حسنين عبدالله
Request type: مبادره
Hospital no: صحة المرأه
Department:
Referred by: د.مروه حسن
Nature of specimen: Tru Cut Biopsy
Clinical diagnosis: Right breast solid Mass.

Age:43years
Sex: Female
Sub request type:
Pathology no.: 1648-2025
Date of Result: 25/5/2025
Receiving date: 21/5/2025
I.D. Number::28209302102084

Gross pathology :

Multiple grayish white tissue cores up to 2cm long. Totally submitted.

Immunohistochemical Technique:

Sections were prepared from the parafiin block, processed in Benchmark Ultra machine (Ventana) and stained by rabbit monoclonal antibodies using Ultra view HRP DAB as chromogen and hematoxylin as counter-stain. The sections were treated against: ER- PR- Her2- Ki67

Microscopic picture:

Microscopic examination revealed mammary core tissue showed extensive ductal carcinomainsitu (DIC) formed of proliferated intra ductal neoplastic cells with moderate anaplasia with punched out fenestration and central comedo type necrosis and solid subtype. There is focal invasion (<5mm) formed of clusters, nest of anaplastic ductal cells with moderate anaplasia and moderate tendency to form tubules dispersed among desmoplastic stroma.

ER. Strong positive nuclear staining of 80 % tumor cells of invasivecomponent (Allred Score8/8).
PR. Moderate positive nuclear staining of 80% tumor cells of invasive component(Allred Score7/8).
Her2: Weak incomplete membranous staining in more than 10 % of tumor cells, Score (1+).

Ki67: Positive nuclear staining in 10% of tumor cells.

Diagnosis: Right breast solid Mass, Tru Cut Biopsy:
Extensive ductal carcinoma insitu (DCIS) With invasive duct carcinoma (NST) <5mm
(ER: 8/8), (PR: 8/8), (Her2: Score 1+), (Ki67:10 %) of invasive component).

Reported by:
Dr. Nermine Nabil, M.D.
Dr. Mona Mohamed, M.D

Pathology Lab. Manager

Nermine Nabil, M.D

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

جوستاف روسي

مبـــادرة رئيس الجمهورية
لـدعـم صحة المرأة المصرية

100 مليون صحة
مصر

MDT FORM

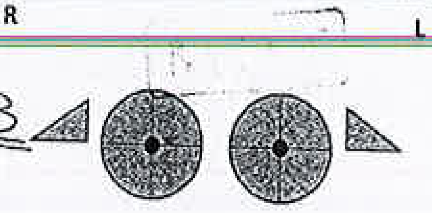
15/9 /2025 G

Name	نعمه السيد حسني	**MRN**	١٩٠٩١٢٥
		ID	٠١١١٤٧٨٦٢٨١
Age	42 years.	**Phone**	٠١١٠٠٤٦١٥٣٠
Menopausal status	Menstruated	**Marital status**	Divorced.
NRS SCORE		**Family history**	+ve.
BMI		**REASON OF MDT**	New case
CO morbidity	HTN, DM, Asthmatic		

Clinical Data ٢٨٣٠٩٢٠٤١٠٢٠٨٢

BX: DCIS & IDC

ER:	**PR:**	**HER 2:**	**Ki67:**
8/8	8/8	+1	1R.L.R.B



Sonomammography: Multicentric masses ē ipsilateral level I.

Mets Workup: Pathological LN ē Microclip at 9-2 o'clock.
CTCAP → Hepatomegaly.

TNM

Recommendations: for clinical and lab correlation
Rt acetabulum tiny sclerotic lesion likely bony island.
· Spondylodegenerative change of the spine.

MDT OUTCOME & PLAN

In view of large N+ (?? N2) disease:
Start NACT (AC×4 → Taxane ×4)
guided by clinical response to
consider ? Rt MRM
(indicate . N1).

- For possible (CEM) from MDT
OR breast
Rt MRM

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric
15/9/2025	15/9/2025				

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL

Patient Name: Ne'ma Al Sayed Hussein Abdel Da'em	Date : 26/08/2025
Exam : CT CAP+C (CT Chest Abd. Pelvis)	Age : 43 Year(s)
Medical ID: 1909/2025	Pat. ID: 111132

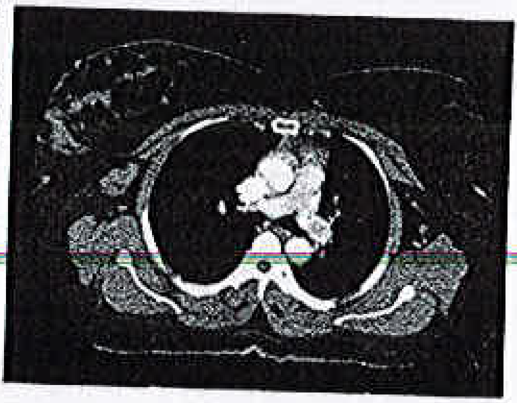
POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST: -

Suboptimal study due to inadequate breast field hindering proper assessment

Clinical History:

- ***Known case of right breast cancer, no available previous films for comparison.***

Findings:



- Right breast heterogeneous parenchyma with architectural distortion.
- Few enlarged suspicious looking axillary lymph nodes are noted, some of which being partially amalgamated, the largest seen measuring 23x16 mm.
- Few left axillary lymph nodes are noted, the largest seen measuring 18x13 mm.
- Both lungs show scattered atelectatic bands.
- No sizable nodules, masses or consolidative patches.
- No sizable hilar or mediastinal lymph nodes.
- Patent tracheo-bronchial tree.
- Normal CT appearance of the mediastinal vessels.
- Average size of the heart.
- No evidence of pleural or pericardial effusion.

OPINION:

- ***Right breast heterogeneous parenchyma with architectural distortion.***
- ***Few enlarged suspicious looking axillary lymph nodes.***
- ***Few left axillary lymph nodes.***

Marina Essam, MSc
Dr.Noura Nabil,MD

MULTI-SLICE CT SCAN OF THE ABDOMEN AND PELVIS: -

Clinical History:

- ***Known case of right breast cancer, no available previous films for comparison.***

CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

وزارة الصحة والسكان
مديرية الشئون الصحية بالجيزة
مستشفى الوراق المركزي

Patient Name [illegible]

Date [illegible]

Sonomammography of the both breasts :-

Findings:

RIGHT BREAST:

[illegible]

Ill defined hypoechoic speculated soft tissue mass lesion of about [illegible] cm in maximum diameters is seen in the upper outer quadrant with architectural distorsion , approximately at 12 O clock 10 cm FFN with evidence of microcalcification (BIRADS 5).

Other few smaller ill-defined hypoechoic speculated soft tissue mass lesions measuring (1.8x 2 cm) in maximum diameters at 11 clock [illegible] at UIQ with evidence of microcalcification (BIRADS 5), another additional ones with same criteria measuring about (1 cm), (0.8 cm) detected around 12 o'clock at UOQ and UIQ.

No evidence of duct ectasia.

No evidence of axillary significant LN .

LEFT BREAST:

[illegible]

Normal size, shape and echopattern of the right breast parenchyma with no definite focal mass lesions

No evidence of duct ectasia.

No significant axillary LN.

IMPRESSION:

Right breast mass for Histopathological verification.

BIRADS category 5

Category 0	Need additional imaging evaluation
Category 1	Normal breast
Category 2	Benign findings
Category 3	Probably benign findings for short interval follow up.
Category 4	Suspicious for biopsy.
Category 5	Highly suggestive malignancy

Yours sincerely
Dr [illegible], MSc

Sonography
[[DOCTYPE:SONOGRAPHY]]